

Si está considerando cirugía para el prolapso de órganos pélvicos, hay varias decisiones que tomar junto con su cirujano. Casi nunca hay **una sola respuesta “correcta”** — el mejor plan depende de su anatomía, su salud y lo que más le importa. Esta hoja repasa las decisiones principales para que pueda conversar con conocimiento.

Las decisiones principales

- **Reparar o cerrar** — reconstruir el soporte (reconstructiva) y mantener la vagina abierta, o cerrar la vagina (colpocleisis) si no planea tener relaciones vaginales.
- **Vía** — por la vagina, o por el abdomen con cirugía laparoscópica o robótica.
- **Su útero** — quitarlo (histerectomía) o conservarlo con una suspensión que lo preserva (histeropexia).
- **Material de soporte** — su propio tejido (reparación nativa), un injerto biológico o malla (malla abdominal, como en la sacrocolpopexia).
- **Escape de orina** — si añadir ahora un procedimiento antiescape (vea abajo).

Sobre el escape oculto

A veces un prolapso grande **oculta** un escape de orina de esfuerzo que solo aparece al corregir el prolapso (incontinencia “oculta”). Su equipo puede evaluarlo y discutir si añadir un cabestrillo a la vez o esperar.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Reconstructiva

Reconstruir el soporte y mantener la vagina funcional.

Obliterativa

Cerrar la vagina (colpocleisis) — muy duradera, termina las relaciones.

Histeropexia

Una suspensión que conserva el útero.

Reparación con tejido nativo

Reparación con solo su propio tejido, sin injerto.

Incontinencia oculta

Escape de esfuerzo oculto que aparece tras corregir el prolapso.

Recurrencia

La posibilidad de que el prolapso vuelva con el tiempo.

¿CÓMO ELIJO? Ajustando las opciones a **sus** prioridades — durabilidad, tiempo de recuperación, conservar el útero, actividad sexual y cómo se siente sobre la malla. Su cirujano recomendará lo que se adapte a su anatomía y salud; la “mejor” opción es la que coincide con sus metas tras una conversación clara.

Preguntas para su cirujano

- ¿Qué **procedimiento(s)** me recomienda y por qué?
- Vía **vaginal o abdominal** — ¿cómo es la recuperación de cada una?
- ¿Puedo (o debo) **conservar mi útero**?
- ¿Usará **mi propio tejido, un injerto o malla** — y qué riesgos hay?
- ¿Necesito un procedimiento **antiescape** ahora o más adelante?
- ¿Cuál es la probabilidad de **recurrencia**, y qué pasa si vuelve?

También conviene saber

- Un **pesario** siempre es una alternativa sin cirugía si prefiere evitarla o retrasarla.
- Controlar el peso, el estreñimiento, la tos y (tras la menopausia) el estrógeno vaginal puede mejorar los resultados.

Cómo prepararse

- Complete los **exámenes preoperatorios** y lleve una lista completa de medicamentos.
- Planee **dejar de fumar** y organice ayuda en casa.
- Conozca la regla general de recuperación: evite levantar peso y las relaciones unas 6 semanas.

Avise a su equipo antes de la cirugía si usted:

- Toma un **anticoagulante** o tiene problemas de sangrado
- Tiene una **infección** actual de orina o vaginal
- Tiene nuevo **dolor** pélvico, **sangrado** o **una llaga que no sana** en el bulto

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La cirugía de prolapso implica varias decisiones — reparar o cerrar, vía, conservar el útero, material de soporte y tratar el escape oculto.
2. Rara vez hay una sola respuesta correcta; el mejor plan coincide con su anatomía y sus prioridades.
3. Haga las preguntas clave, y recuerde que un pesario siempre es una alternativa sin cirugía.